

LES OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES

Objectifs pédagogiques :

- ✓ Définir une occlusion intestinale aiguë.
- ✓ Expliquer les mécanismes étiopathogénies des occlusions intestinales aiguës.
- ✓ Expliquer les conséquences physiopathologiques d'une occlusion intestinale aiguë.
- ✓ Etablir le diagnostic positif d'une occlusion intestinale aiguë à partir des données de l'examen clinique et de l'imagerie.
- ✓ Reconnaître les signes de gravité d'une occlusion intestinale aiguë.
- ✓ Réunir les éléments cliniques et para cliniques permettant d'identifier le niveau, le mécanisme et l'étiologie de l'occlusion intestinale aiguë.
- ✓ Planifier la prise en charge thérapeutique.

I. INTRODUCTION – DEFINITION :

- **Définition :** L'occlusion intestinale aiguë se définit comme étant un arrêt complet et permanent du transit composé de gaz et de matières, dans un segment intestinal.
- **Intérêt du sujet :**
 - ✓ Elle représente une des urgences chirurgicales les plus fréquentes (la deuxième cause de douleur abdominale aiguë après l'appendicite aiguë) et les plus graves, qui peut en cas de retard de prise en charge, mettre en jeu le pronostic vital par le risque de nécrose intestinale et les troubles hydroélectrolytiques qu'elle engendre.
 - ✓ Elle ne constitue pas une maladie, mais un syndrome dont les causes sont multiples et les mécanismes sont variables.
 - ✓ Elle se voit à tout âge et plus grave aux âges extrêmes de la vie, sans prédominance de sexe.
 - ✓ Son diagnostic repose sur les données de l'examen clinique « le carré des occlusions » et la présence de niveaux hydroaériques sur la radiographie de l'abdomen sans préparation en position debout. Son diagnostic étiologique a largement bénéficié des progrès du scanner.
 - ✓ Le traitement vise à rétablir le transit intestinal et à traiter la cause afin de prévenir les récurrences.
 - ✓ Le pronostic est multifactoriel et dépend essentiellement de la précocité de la prise en charge.

II. ETIOPATHOGENIE :

Il existe 3 types d'occlusions : occlusions mécaniques, occlusions fonctionnelles et les occlusions mixtes.

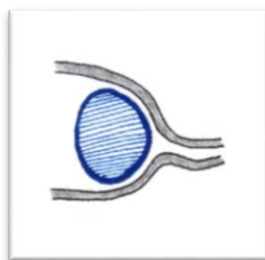
II.1. Occlusions mécaniques :

Provoqué par un obstacle organique, soit dû à une obstruction ou à une strangulation.

❖ Les occlusions par obstruction :

L'obstruction n'intéresse que la lumière intestinale, la cause peut être : un obstacle endoluminal, un obstacle pariétal ou une compression extrinsèque.

- ✓ **Obstacle endoluminal :** au niveau du grêle la lumière intestinale peut être obstruée par des corps étrangers Le type est l'iléus biliaire (migration d'un calcul dans l'intestin par l'intermédiaire d'une fistule bilio-digestive), un fécalome chez le vieillard, phytobézoard (qui correspond à des aliments indigestes riches en cellulose et ingérés en grande quantité chez des patients édentés), les parasitoses intestinales (les amas d'ascaris chez l'enfant).

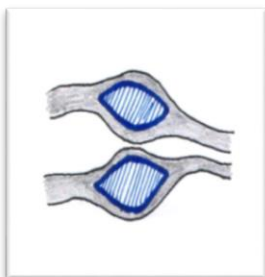


✓ **Obstacle pariétal :**

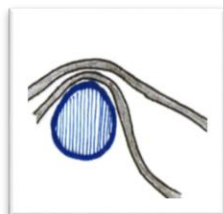
Une tumeur bénigne ou maligne du grêle ou du colon.

Un rétrécissement de la lumière intestinale par épaissement inflammatoire de la paroi, ou par rétraction scléreuse.

Exemple : une sténose chronique de nature tuberculeuse ou observée au cours d'une maladie de Crohn, ou cicatricielle (post-opératoire, post-traumatique, ou post-radique).



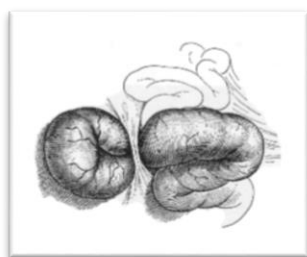
✓ **Une compression extrinsèque :** par une tumeur d'un organe de voisinage qui peut être bénigne (kyste de l'ovaire, fibrome) ou maligne (carcinose péritonéale).



❖ **Les occlusions par strangulation :** Les plus graves.

La strangulation est une striction serrée qui intéresse non seulement le segment intestinal mais aussi le contenu vasculaire de son méso. Elle entraîne non seulement une dilatation intestinale en amont mais surtout une ischémie intestinale qui va aboutir à des lésions graves de nécrose et de perforation, en l'absence de traitement chirurgical urgent. Cette strangulation se produit de différentes manières :

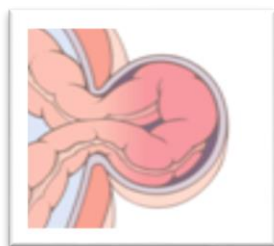
✓ Par brides et adhérences post-opératoire.



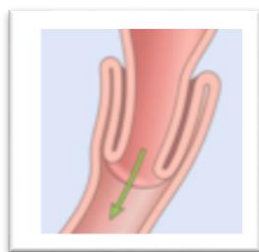
✓ Par torsion d'une ou plusieurs anses autour de leurs axe mésentérique ; « C'est le volvulus ».



- ✓ Par étranglement dans un anneau de striction congénitale ou acquis ; « C'est l'étranglement herniaire ». L'étranglement se fait à travers un orifice externe (pariétal) ou interne.



- ✓ Par télescopage d'un segment intestinale dans celui situé immédiatement en aval ; « C'est l'invagination intestinale aiguë ».



II.2. Les occlusions fonctionnelles :

Ces occlusions sont secondaires à une paralysie de la motricité intestinale, en l'absence de tout obstacle mécanique. Elles sont soit :

❖ Inflammatoires :

L'inflammation de la séreuse péritonéale provoque la paralysie de la musculature sous-jacente. Ce mécanisme se voit dans les péritonites aiguës où les anses baignent dans un liquide purulent et les foyers inflammatoires circonscrits : (Abcès appendiculaires, abcès pelvien, appendicite méso-coeliaque, un diverticule de Meckel infecté, une sigmoïdite).

❖ Réflexes :

Colique néphrétique, hématomes rétropéritonéaux.

❖ Métabolique :

Une hypokaliémie ou une hypocalcémie, d'où la règle absolue de demander un ionogramme devant une occlusion intestinale aiguë.

II.3. Les occlusions mixtes :

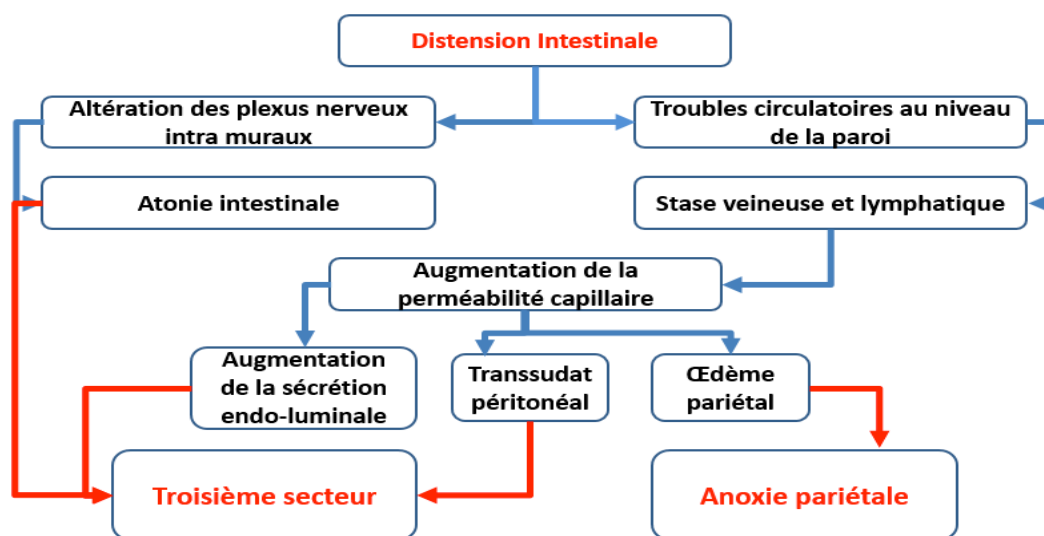
Une occlusion fonctionnelle peut devenir mécanique lorsque l'anse irritée s'alourdit par les sécrétions qui s'y accumulent capote sur elle-même entraînant une occlusion. Inversement une occlusion mécanique partielle peut devenir totale lorsqu'un facteur fonctionnel se surajoute.

III. PHYSIOPATHOLOGIE :

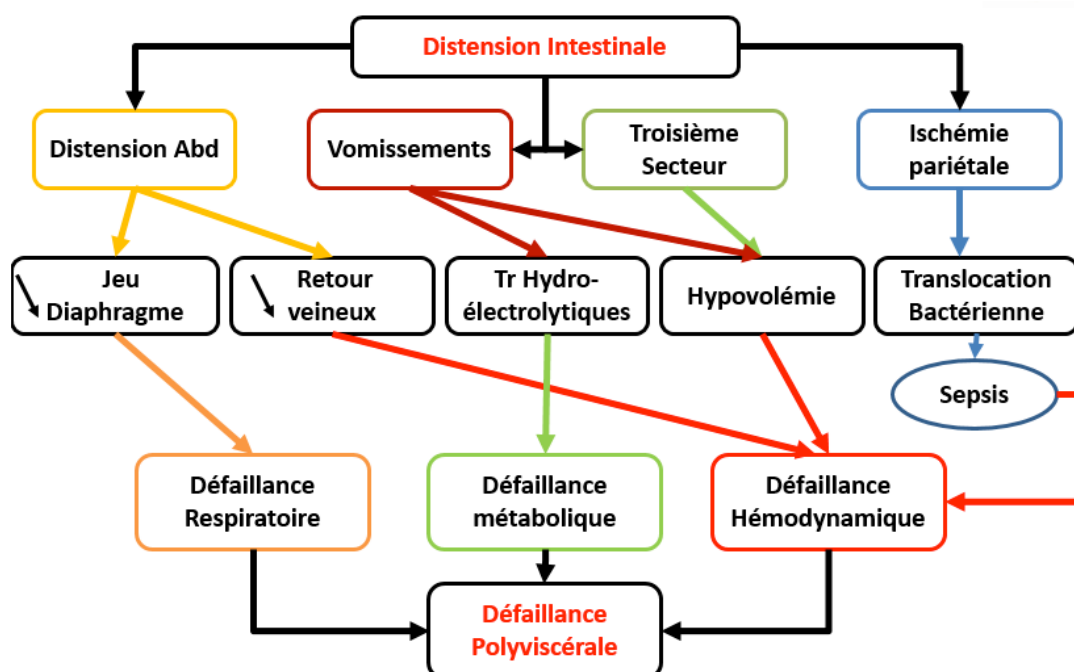
L'obstacle intestinal est à l'origine d'une distension intestinale d'amont.

La distension engendre des phénomènes locaux et des phénomènes généraux avec comme résultat stase et ischémie locales à l'origine d'une séquestration dans la lumière intestinale d'eau et des ions ce qui produit une hypovolémie, des

troubles ioniques et acido-basiques, aggravés par les vomissements. Le troisième secteur ainsi créé est représenté par la lumière intestinale, l'œdème viscéral et l'épanchement intra péritonéal. Si l'occlusion évolue tardivement jusqu'à la nécrose et la perforation de l'anse intestinale alors la péritonite rajoute les effets du choc septique sur le retentissement viscéral.



Conséquences locales de l'occlusion intestinale aiguë.



Conséquences générales de l'occlusion intestinale aiguë.

IV. DIAGNOSTIC POSITIF :

Le diagnostic d'occlusion est établi sur des éléments radio cliniques.

IV.1. Tableau clinique :

Le diagnostic clinique d'occlusion intestinale repose sur l'association de 4 signes cardinaux : **Carré des occlusions ou carré de Mondor : Douleur abdominale, vomissements, arrêt des matières et des gaz, et météorisme abdominal.**

La qualité de chacun de ces signes varie en fonction du siège et de l'étiologie de l'occlusion.

❖ Signes fonctionnels :

• Douleur abdominale :

Constante ; continue ou intermittente à type de coliques abdominales. D'installation brutale et alors souvent permanente ou progressive, présentant un caractère rythmique qui traduit la lutte de l'intestin contre l'obstacle sous-jacent. Son siège initial doit être recherché. D'intensité variable, allant de l'état de mal suraigu, atroce (perforation) à une simple gêne. Son évolution est spasmodique, aboutissant à un endolorissement diffus, par distension intestinale majeure.

• Vomissements :

Précoces ou tardifs, parfois absents. Alimentaires et bilieux, fécaloïdes à un stade avancé. Ces vomissements sont d'autant plus tardifs que l'occlusion est de siège distal. Ils soulagent la douleur une fois sur trois dans les occlusions du grêle et rarement dans les occlusions du côlon.

• Arrêt des matières et des gaz : « AMG »

Signe clinique majeur qui définit l'occlusion intestinale complète. L'arrêt des gaz précède l'arrêt des matières, en raison de la possibilité de vidange du segment intestinal situé en aval de l'obstacle.

❖ Signes généraux :

L'examen général doit rechercher :

- **Les signes de retentissement de l'occlusion** : Signes de déshydratation et d'hypovolémie : tachycardie, hypotension artérielle et oligurie.
- **Les signes témoignant d'une nécrose intestinale** : fièvre et tachycardie.

❖ Signes physiques :

➤ L'inspection :

- Note en premier, l'existence éventuelle d'une cicatrice de laparotomie ou des orifices de trocars de coelioscopie pouvant évoquer la possibilité d'une occlusion sur brides.
- Montre un météorisme abdominal ou ballonnement et précise son caractère : généralisé ou localisé, symétrique ou diffus, immobile (traduisant une inertie intestinale) ou bien actif animé d'ondulations péristaltiques spontanées ou provoquées par la douleur.

➤ La palpation :

- Il existe une résistance élastique de la paroi, pas de contracture ni défense. L'existence d'une défense localisée peut traduire la souffrance d'une anse intestinale.
- On doit systématiquement palper les orifices herniaires (inguinal, crural, ombilical) pour éliminer une hernie étranglée.

➤ La percussion : Met en évidence :

- Une sonorité tympanique généralisée ou localisée.
- Une matité traduit une anse pleine ou un épanchement péritonéal.

➤ L'auscultation abdominale : peut retrouver :

- Soit des borborygmes (bruits aérodigestifs exagérés) en rapport avec un hyper-péristaltisme en amont de l'obstacle,
- Soit un silence abdominal qui traduit la distension et la paralysie de l'intestin (iléus paralytique) ou l'absence de vitalité de l'anse étranglée (strangulation).

➤ Toucher rectal :

- Vérifie la vacuité de l'ampoule rectale.
- Permet parfois de retrouver la cause de l'occlusion (fécalome, le pôle inférieur d'une tumeur rectale), rectorragie signe important d'invagination intestinale ou de souffrance intestinale.

➤ Trois gestes fondamentaux à ne pas oublier (+++) :

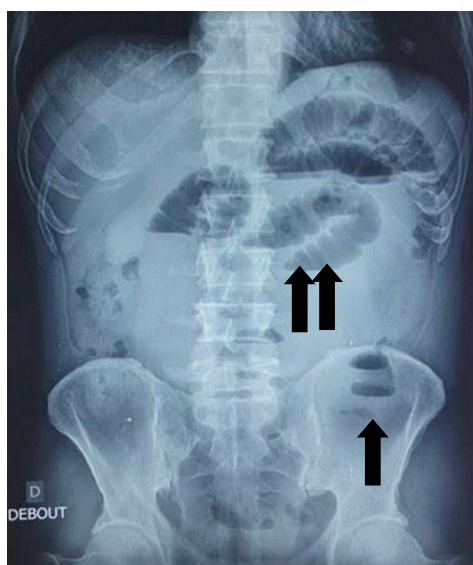
- Recherche d'une cicatrice abdominale.
- Examen des orifices herniaires.
- Toucher rectal.

IV.2. Signes radiologiques :

IV.2.1. Radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) : « de face debout, de face couché, centré sur les coupes diaphragmatiques » est l'examen clé à réaliser.

➤ ASP debout de face :

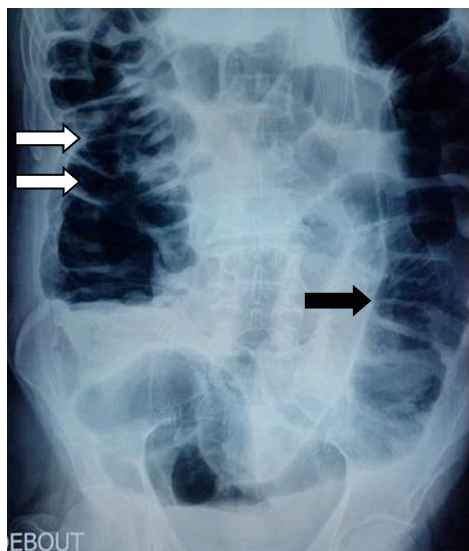
- Montre le signe radiologique fondamental : les niveaux hydroaériques, qui traduisent la présence de liquide surmonté par de l'air dont il faut préciser le nombre, la forme et le siège.
- Précise le segment intestinal dilaté.
- Recherche des images aériques extra digestives : un pneumopéritoine ou une aérobie (présence d'air dans les voies biliaires).



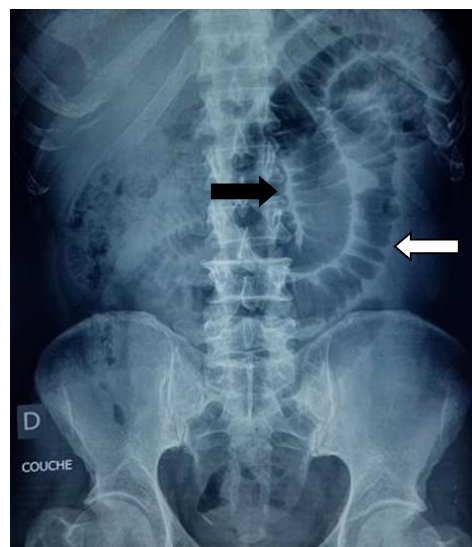
Radiographie d'abdomen sans préparation debout montrant un arceau (flèche simple) et une bulle gazeuse (double flèche).

➤ Cliché de face couché : Il a un double intérêt :

- Apprécier le degré de distension intestinale : Par exemple, le cæcum est pré perforatif à 11cm de diamètre, le grêle à 7 cm.
- Confirmer qu'il s'agit bien :
 - D'une occlusion du grêle : Présence de valvules conniventes.
 - D'une occlusion du colon : Présence de haustrations coliques.



ASP montrant des haustrations coliques (flèches).



ASP montrant des valvules conniventes (flèches).

IV.2.2. Scanner abdominal : le gold standard dans la prise en charge des syndromes occlusifs. Il permet :

- D'affirmer le diagnostic de l'occlusion en objectivant les niveaux hydroaériques et en appréciant le diamètre de l'intestin (présence d'anses grêles dilatées de diamètre supérieur ou égal à 25 mm et/ou d'un côlon de diamètre supérieur ou égal à 60 mm).
- Déterminer le caractère mécanique ou fonctionnel de l'occlusion.
- Préciser le siège de l'obstacle et sa nature (Le niveau de l'obstacle siège entre l'intestin dilaté et l'intestin plat).
- Déterminer la présence de signes de gravité (perforation, pneumatose pariétale, anomalies de rehaussement des anses).
- Trouve particulièrement son indication dans les occlusions sur abdomen non cicatriciel et en dehors des hernies étranglées.
- Irremplaçable pour écarter les diagnostics différentiels.

IV.2.3. Echographie abdominale :

Sa place, dans le syndrome occlusif, est très restreinte en raison de la présence de gaz contenu dans les anses intestinales dilatées, elle peut néanmoins se révéler utile chez l'enfant (suspicion d'invagination), en cas d'iléus biliaire, une occlusion inflammatoire ou en cas de grossesse.

IV.2.4. Les opacifications digestives aux hydrosolubles :

Soit hautes (opacification à la gastrograffine) soit basses (lavement aux hydrosolubles), elles servent surtout à préciser le siège de l'obstacle en opposant les obstacles du grêle ou le colon est injecté en totalité à ceux du colon où le produit bute sur l'obstacle du segment colique intéressé et peuvent parfois évoquer sa nature.

Actuellement, elles sont de moins en moins réalisées au profit de la tomodensitométrie abdominale.

IV.3. Signes biologiques :

Le but des examens biologique est de juger du retentissement général de l'occlusion et apprécier sa gravité.

- Rechercher une insuffisance rénale (urée sanguine et créatinine).
- Rechercher le déséquilibre acido-basique et hydroélectrolytique (ionogramme sanguin).
- Rechercher les signes prédictifs d'une ischémie intestinale : hyperleucocytose ($> 18000 \text{ GB/mm}^3$) et l'hyperkaliémie.

V. Diagnostic de gravité

Les signes témoignant de la gravité d'une occlusion intestinale doivent être systématiquement recherchés :

V.1. Signes cliniques :

V.1.1. Signes généraux :

- Fièvre dans les occlusions mécaniques son apparition témoigne d'une nécrose intestinale.
- Signes de déshydratation surtout chez l'enfant et le vieillard. La soif, la sécheresse de la bouche, le pli cutané persistant, la tachycardie, l'hypotension voire un collapsus, oligurie puis anurie.
- Signes de choc.

V.1.2. Signes péritonéaux :

- Défense abdominale et cri de Douglas au toucher rectal : Synonyme de souffrance intestinale.
- Contracture abdominale (témoignant d'une perforation).

V.1.3. Signes digestifs :

- Vomissements fécaloïdes.
- Sang au toucher rectal (témoignant d'une ischémie).

V.2. Signes biologiques :

- La numération formule sanguine peut montrer :
 - Une élévation de l'hématocrite (déshydratation).
 - Une hyperleucocytose $> 18000/\text{mm}^3$ en cas de nécrose intestinale.
- L'ionogramme sanguin peut montrer :
 - Une alcalose hypochlorémique dans les occlusions proximales avec vomissements abondants.
 - Une acidose hypokaliémique dans les occlusions distales.
 - Une hyponatrémie en raison de la teneur élevée en sodium des liquides digestifs.
 - Une hyperkaliémie en cas de nécrose.
- Une azotémie élevée par insuffisance rénale.

V.3. Signes radiologiques :

- Un pneumopéritoine sur la radiographie d'ASP.
- TDM : signes d'ischémie intestinale : Paroi intestinale « Non rehaussée au C+, siège de pneumatose », perforation.
- Anomalies de rehaussement des anses.
- Aéroportie.
- Dans les occlusions coliques, un diamètre caecal dépassant les 12 cm est considéré comme signe de gravité témoignant d'un risque imminent de perforation diastatique.

VI. DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE (SIEGE) : repose sur un faisceau d'arguments cliniques et radiologiques.

Cependant dans 50% des cas la clinique et la radiographie de l'ASP ne permettent pas de distinguer une occlusion haute d'une occlusion du colon d'où l'intérêt de réaliser un scanner abdominopelvien qui permet de préciser le siège exact sur le cadre colique et sur l'intestin grêle « proximal ou distal », le mécanisme et la cause de l'occlusion.

	OIA haute	OIA basse
Siège	Sur le duodénum et l'intestin grêle en amont de la valvule de Bauhin.	L'obstacle siège sur le cadre colique ou le rectum.
Début	Rapide, brutal.	Insidieux et progressif.
Douleurs	Vives, localisées, Permanentes.	Modérées, diffuses, Paroxystiques.
Vomissements	Précoces, abondants.	Rares et tardifs.
Arrêt des matières et des gaz	Tardif et peu net.	Absolu, et précoce, avec arrêt net des gaz ++
Etat général	Précocement altéré.	Longtemps conservé.
Météorisme	Discret, central et péri- ombilical, parfois absent, voir ventre plat	Volumineux, en cadre ou asymétrique.
Radio ASP de face debout : « NHA »	Multiples, centraux, fins, plus large que hauts. Absence de gaz dans le colon.	Peu nombreux, périphériques, plus haut que larges. Présence de gaz dans le colon.
Radio ASP de face couché :	On voit des valvules conniventes réalisant des fines incisures allant d'un bord à l'autre de l'intestin dilaté.	On voit des haustrations, larges incisures asymétriques n'allant pas d'un bord à du colon dilaté.

Différenciation radio-clinique entre occlusion haute et basse.

VII. DIAGNOSTIC DE MECANISME :

Reconnaître le mécanisme de l'occlusion est d'une importance capitale car il conditionne la stratégie thérapeutique. Ce diagnostic est basé sur l'analyse des données :

- **Cliniques** : Mode de début et intensité du syndrome occlusif, l'EG et l'examen de l'abdomen,
- **Radiologiques** : Existence ou non de « Disparité de calibre intestinale, Signes de souffrance intestinale.

VII.1. Occlusion mécanique ou fonctionnelle ?

	OIA mécanique	OIA fonctionnelle
Douleurs	Intenses et localisées/ Modérées et diffuses	En rapport avec la pathologie causale : (Coliques néphrétiques)
Fièvre	Absente	Présente
Arrêt des matières et gaz	Présent	Pas évident
Météorisme	Discret ou diffus	Diffus
Auscultation	Bruits hydroaériques, gargouillement	Silence
Radio ASP	Grêle ou Colon	Dilatation diffuse du grêle (aéroiléie) et/ou du colon (aérocolie).
Scanner	Disparité de calibre de l'intestin	Distension gazeuse ou liquidienne globale et diffuse à tout l'intestin sans zone de disparité de calibre

Différenciation radio-clinique entre occlusion mécanique et fonctionnelle.

VII.1. Strangulation ou obstruction ?

	Strangulation	Obstruction
Mode de début	Brutal	Progressif
Phase pré occlusive	Non	Oui Quand l'occlusion siège sur l'intestin grêle : Syndrome de Koenig Quand l'obstacle est colique : Constipation opiniâtre
Douleur	Vive syncopale	Modérée
Vomissements	Présents et abondants	Peu marqués (selon le siège)
Arrêt des matières et gaz	Brutal	Progressif
Etat Général	Altérée	Conservée
Météorisme	Discret	Diffus
Auscultation	Silence auscultatoire	Bruits HA conservés voir exagérés
Radio ASP	Image en arceau avec un niveau liquide à chaque pied	Nombreux Niveaux hydroaériques
TDM	Disparité de calibre Visualise l'obstacle et éventuels signes de souffrance intestinale	Disparité de calibre Objective l'obstacle qui est pariétale ou intraluminal

Différenciation radio-clinique entre occlusion mécanique par strangulation et par obstruction.

NB : Le syndrome de Koenig fait de douleurs abdominales migratrices déclenchées par les repas, aboutissant toujours au même point et cédant brutalement avec une sensation de gargouillement associé à un bruit de filtration hydroaérique et parfois, une « débâcle » diarrhéique.

VIII. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : Peuvent être discutées :

- Certaines affections médicales provoquant un iléus réflexe tel que l'infarctus du myocarde à forme abdominale, la colique néphrétique et Le saturnisme.
- Une hypokaliémie peut être à l'origine d'un iléus réactionnel d'où l'intérêt de la pratique d'un ionogramme devant tout syndrome occlusif.
- Un iléus paralytique accompagnant un sepsis abdominal (péritonite), une appendicite méso-cœliaque, une cholécystite pseudo-occlusive.
- Une pancréatite aigüe ou un Infarctus entéro-mésentérique.
- Hématomes rétropéritonéaux après traumatismes abdominaux violents.

IX. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :

IX.1. Eléments du diagnostic étiologique :

Le diagnostic du siège de l'occlusion, de son mécanisme et l'analyse du terrain orientent l'enquête étiologique. L'analyse du terrain est basée en plus de l'âge sur la recherche :

- Des antécédents de chirurgie abdominale ou pelvienne et la nature de l'intervention subie.
- Des antécédents de pathologie néoplasique traitée chirurgicalement ou par radiothérapie, d'une maladie inflammatoire intestinale chronique, d'un terrain vasculaire (intoxication alcoolique tabagique, HTA, Diabète ...).
- De la notion d'une constipation récente, de la majoration d'une constipation chronique, de crises subocclusives ou de la présence de sang dans les selles.

- De la nature et la posologie des traitements suivis : diurétiques, anticoagulants, antiparkinsoniens ou neuroleptiques.

La TDM reste l'examen clé qui permet de visualiser la cause exacte de l'occlusion et sa nature.

IX.2. Principales étiologies :

IX.2.1. Occlusion mécanique de l'intestin grêle :

❖ Par strangulation :

➤ Les occlusions sur brides :

La bride est un filament fibreux accolant les viscères entre eux et à la paroi abdominale ; elle se forme en post opératoire au contact des anastomoses, des zones dépéritonisées et des surfaces inflammatoires.

Cause la plus fréquente des occlusions du grêle. C'est avant tout une maladie du patient laparotomisé.

➤ Volvulus du grêle :

Torsion de l'intestin grêle et de son méso sur son axe.

Causes : brides, malrotations mésentériques.

Douleur brutale, intense, précocité des vomissements et des signes généraux, arrêt incomplet du transit avec retentissement rapide sur l'état général et météorisme central, immobile, silencieux.

➤ Hernie et éventrations étranglées :

Grande fréquence justifie l'examen systématique des orifices herniaires devant toute occlusion intestinale aiguë (+++). Il peut s'agir d'une hernie inguinale ou crurale, plus rarement ombilicale.

Le diagnostic est porté devant **une tuméfaction douloureuse** avec un maximum au collet, **irréductible et non impulsive à la toux**.

➤ L'invagination intestinale aiguë :

C'est la pénétration d'un segment intestinal et de son méso dans le segment situé en aval (intussusception) et sa progression dans le sens iso péristaltique.

Fréquente chez le nourrisson et l'enfant, l'occlusion est spontanée. Moins fréquente chez l'enfant et rare chez l'adulte, où elle est habituellement secondaire à une tumeur du grêle, du mésentère ou à un diverticule de Meckel.

❖ Par obstruction :

➤ Iléus biliaire :

Complication rare et retardée d'une cholécystite négligée. Il s'agit d'un volumineux calcul vésiculaire qui a migré dans le duodénum à travers une fistule entre la vésicule biliaire et le duodénum (fistule cholécysto-duodénale), ce calcul se bloque dans l'iléon terminal, près de la valvule iléo-cæcale.

Clinique : Occlusion du grêle par obstruction chez une femme connue porteuse d'une lithiase vésiculaire ou antécédente de coliques hépatiques fébriles.

L'ASP montre des niveaux liquides et une aérobilie (présence d'air dans les voies biliaires en provenance du duodénum). L'échographie confirme le diagnostic en montrant une aérobilie.

Le diagnostic pourra être précisé par une opacification du tube digestif (transit aux hydrosolubles) qui révélera la fistule bilio digestive et localisera le calcul en donnant la classique image « en tête de serpent ».

➤ Tumeurs du grêle :

Rares chez l'adulte. La clinique est dominée par le syndrome de Koenig : douleurs localisées, survenant par crises, augmentant rapidement d'intensité, disparaissant avec des bruits hydro-aériques, répétées, de fréquence croissante.

➤ Sténoses inflammatoires :

Peuvent compliquer une maladie de Crohn, une tuberculose iléo cæcale, une radiothérapie... Le diagnostic peut souvent être évoqué à l'anamnèse et confirmé par le scanner.

- **Autres causes** : Carcinose péritonéale. Bézoard et corps étrangers ingérés volontairement, parasites, Hématome pariétal (accident des AVK).

IX.2.2. Occlusion mécanique du colon :

❖ Par strangulation :

➤ **Le volvulus du colon sigmoïde ou pelvien VCP :**

C'est la torsion de l'anse sigmoïde autour de son axe mésocolique. Il est favorisé par l'existence d'une boucle sigmoïdienne longue de 80 cm avec méso court.

Il survient en général chez le sujet âgé autour de 60 ans, parfois psychotique sous neuroleptique, aux antécédents de constipation chronique avec épisodes sub occlusifs spontanément résolutifs.

Le début est brutal, marqué par des douleurs diffuses et modérées, vomissements absents, un arrêt des matières et des gaz net et absolu.

Les signes retrouvés à l'examen physique constituent les éléments de la classique **triade de VON WAHL**, traduction fidèle de l'anse volvulée : **météorisme asymétrique, tympanique, résistant et immobile**. Au toucher rectal, l'ampoule rectale est vide. Parfois, on peut percevoir le pied du volvulus au sommet de l'ampoule.

Sur la Radiographie de l'ASP l'image typique est celle d'un arceau à double jambage ; Une énorme clarté gazeuse en U renversé avec deux niveaux hydro- aériques au pied des deux jambages, décalés l'un par rapport à l'autre.

La TDM avec opacification colique : confirme le diagnostic en montrant une image d'arrêt effilé au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne à raccordement obtus avec le rectum « **image en bec d'oiseau** ».

➤ **Volvulus du cæcum ou du colon droit :**

Il est rare, le tableau réalisé est celui d'une occlusion du grêle par strangulation avec un début brutal marqué par Douleurs FID associées à des vomissements précoces, météorisme épigastrique et la FID est vide.

L'ASP : volumineux niveau hydroaérique se projetant au niveau de l'hypochondre droit et une dilatation du grêle. La fosse iliaque droite est déshabillée. Le diagnostic est confirmé par l'opacification basse (lavement aux hydrosolubles ou scanner avec opacification).

❖ Par obstruction :

❖ **Les cancers coliques :**

Cause de plus de la moitié des occlusions du colon. Accident évolutif classique des cancers du côlon gauche (sigmoïde, ou l'angle gauche).

Terrain : Patient présentant un passé de troubles du transit « alternance diarrhées et constipation », rectorragies, émissions anormales et / ou les facteurs de risque de cancer colorectal.

Clinique : Tableau d'une OIA basse par Obstruction : Début progressif : douleurs abdominales FIG, AMG précoce, vomissements tardifs,

Météorisme abdominal diffus ou en cadre, et tympanisme diffus avec parfois ondulations péristaltiques et bruits hydro-aériques conservés voir même exagérés,

Rechercher une sensibilité ou une défense de la FID (risque de perforation in situ ou du segment intestinal d'amont « perforation diastatique du cæcum » avec péritonite stercorale),

Toucher rectal peut révéler l'étiologie : tumeur rectale.

La Radiographie de l'ASP montre des niveaux hydroaériques plus hauts que larges, peu nombreux, périphériques et apprécie le diamètre du cæcum.

TDM avec opacification basse aux hydrosolubles confirment le diagnostic : sténose colique ou rectale d'allure maligne. (Sténose courte, serrée, excentrée, avec anomalies muqueuses, et angle de raccordement aigu avec le colon).

➤ **Autres causes :**

Fécalome, Sténose inflammatoire ou cicatricielle (sur sigmoïdite, sténose anastomotique...).

IX.2.3. Occlusions fonctionnelles :

Il s'agit d'un iléus paralytique du le plus souvent à une faillite du péristaltisme de l'intestin. Il peut être secondaire) un trouble métabolique, une prise médicamenteuse, une hypothyroïdie ou une maladie générale.

➤ **Causes idiopathiques :**

- ✓ **Pseudo-obstruction idiopathique chronique de l'intestin :** Il s'agit d'un défaut de l'innervation intestinale qui se manifeste des épisodes occlusifs à répétition sans obstacle lésionnel séparés par des périodes de diarrhées avec altération de l'état général. Le diagnostic est histologique par des biopsies jéjunales étagées

Pseudo-occlusion colique aigue (Syndrome d'Ogilvie) : C'est une dilatation colique sans obstacle mécanique survenant le plus souvent dans les suites d'un polytraumatisme, chez des malades intubés-ventilés, chez des patients âgés alités, ou des patients diabétiques présentant des troubles neurologiques (maladie de Parkinson) ou psychiatriques.

La radiographie de l'ASP : Absence de NHA mais existe une distension diffuse du cadre colique « aérocolie » et du rectum.

TDM : En dehors de l'aérocolie la TDM confirme le diagnostic en montrant l'absence de tout obstacle mécanique ou foyer septique intra- abdominal.

Intérêt d'une coloscopie pour exsuffler le colon

X. TRAITEMENT :

X.1. But :

- ✓ Lutter contre les conséquences physiopathologiques de l'occlusion.
- ✓ Lever l'obstacle et rétablir le transit intestinal.
- ✓ Traiter la cause et prévenir les récives.

X.2. Moyens :

❖ **Traitement médical :** Il vise à corriger les désordres hydroélectrolytiques et acido-basiques :

- ✓ Prise d'une voie veineuse pour remplissage vasculaire et réhydratation.
- ✓ Correction de la volémie par perfusion de macromolécules, de sérum physiologique.
- ✓ Correction des troubles ioniques en fonction du résultat des ionogrammes.
- ✓ Mise en place d'une sonde naso-gastrique en aspiration pour prévenir et quantifier les vomissements (on compensera les volumes aspirés), réduire l'accumulation des liquides, rompre le cercle vicieux de la distension et de l'ischémie et parfois reprendre le transit intestinal.
- ✓ Correction des insuffisances viscérales liées au 3ème secteur.
- ✓ Pose d'une sonde vésicale pour surveiller la diurèse horaire.
- ✓ Les antibiotiques ne sont indiqués qu'en cas d'infection associée : occlusions fébriles ou nécrose intestinale.

❖ **Traitement endoscopique :**

Il permet dans certaines occlusions coliques de lever l'obstacle et de rétablir le transit intestinal permettant de réaliser le traitement chirurgical définitif de la cause dans des meilleures conditions.

- ✓ Mise en place d'une endoprothèse métallique "stent".
- ✓ Exsufflation ou détorsion endoscopique d'un volvulus sigmoïdien.

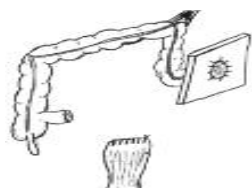
❖ **Traitement Chirurgical :** Consiste à lever l'obstacle de l'occlusion « traitement étiologique ».

X.3.Méthodes et Indications :

Les méthodes dépendent de l'étiologie.

- ✓ **En cas de brides :**
 - Section des brides.
 - Sections des brides avec résection intestinale si vitalité compromise. Le rétablissement se fait souvent en un seul temps.
- ✓ **En cas de hernie étranglée :**
 - Réduction et cure de la hernie par voie élective.
 - Résection intestinale et rétablissement de la continuité par voie médiane si nécrose intestinale.

- ✓ **En cas d'iléus biliaire** : Si le calcul ne peut être repoussé dans le caecum, il sera extrait par entérotomie suivie de suture. La fistule bilio-digestive est souvent traitée en un second temps.
- ✓ **En cas de tumeur sténosante du grêle** : résection + anastomose habituellement en un seul temps.
- ✓ **En cas de tumeur sténosante du colon gauche** :
En cas de souffrance du colon d'amont « pneumatose pariétale » ou de colectasie une colectomie totale avec anastomose iléo rectale est réalisée en urgence. En l'absence de ces signes, plusieurs alternatives thérapeutiques sont possibles :
 - Soit pose d'une endoprothèse par colonoscopie suivie secondairement de la chirurgie
 - Soit colostomie de proche amont (laissant la tumeur en place). Geste rapide et simple, ayant pour but de rétablir le transit en amont de l'obstacle. C'est le traitement de l'occlusion en urgence. Le traitement étiologique et le rétablissement se feront en un deuxième temps.
 - Soit résection colique gauche emportant la tumeur et confection d'une colostomie type Hartmann ou Bouilly-Volkman. Le rétablissement de la continuité se fait après préparation adéquate du malade et exploration colique.
 - Soit d'emblée une colectomie carcinologique avec anastomose colorectale.
- ✓ **En cas de tumeur sténosante du colon droit** : Résection colique droite et rétablissement iléo-transverse en un seul temps.
- ✓ **Volvulus du colon** : en cas d'échec ou de contre-indications à la détorsion endoscopique ; résection colique et rétablissement de la continuité en un temps ou en deux temps (2 à 3 mois plus tard).



Colostomie type Hartmann.



Colostomie type Bouilly Volkman.

- ✓ **En cas de syndrome d'Ogilvie** :

L'exsufflation par colonoscopie est le traitement de base, au besoin répétée en cas de récurrence pour éviter la perforation diastatique du côlon droit. La chirurgie n'intervient qu'en présence de complications (nécrose ou perforation cæcale).

CONCLUSION :

Les occlusions intestinales aiguës représentent une urgence médico-chirurgicale pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Le diagnostic d'une occlusion mécanique et son degré de gravité doivent être précisés le plus rapidement possible, car un retard d'une intervention chirurgicale, lié le plus souvent à une erreur de diagnostic, accroît la mortalité en particulier en cas d'ischémie pariétale associée.